

Manifestations neuropsychiatriques et anticorps **anti-NMDAR** : une porte d'entrée complexe vers le diagnostic de lupus

FZ. SENHADJI¹, H. ATTIA², N. BOUDJADI³

¹ Établissement Public Hospitalier de Tabia, Sidi Bel Abbès ² EHU Oran ³ CHU Sétif

Introduction

- L'**encéphalite limbique auto-immune (ELAI)** se manifeste de façon souvent stéréotypée par une perte de mémoire, des convulsions et des troubles psychiatriques d'évolution rapide, le plus souvent en lien avec des **anticorps anti-NMDAR**.
- Le **lupus érythémateux systémique (LES)** est une pathologie auto-immune chronique pouvant toucher le système nerveux central (**neurolupus**) et mimer parfaitement le tableau d'une encéphalite primitive, y compris sur le plan biologique (anti-NMDAR positifs).

Objectif

- Illustrer, à travers l'évolution d'un même cas, la difficulté à distinguer une **encéphalite auto-immune primitive** d'un **neurolupus**, et l'intérêt d'une réévaluation diagnostique devant toute rechute atypique.

Observation clinique

Patiente de 31 ans, G1POA0, sans antécédents personnels particuliers.
Antécédents familiaux : père hypertendu et diabétique ; sœur suivie pour thyroïdite d'Hashimoto et néoplasie mammaire.

- **Mars 2023 — 1^{er} épisode**
Crises convulsives généralisées, céphalées intenses, troubles de la vision et paraparésie. **IRM** : hypersignaux de la substance blanche sus- et sous-tentoriels et juxta-corticaux bilatéraux, à prédominance gauche. Sortie sous Képpra après stabilisation.
- **Avril 2024 — 2^e épisode**
Crises convulsives, déficit moteur et sensitif, confusion et troubles de la mémoire, dans un contexte de **prééclampsie sévère compliquée d'un syndrome HELLP**, avec lésions papuleuses croûteuses au siège intercostal.
- **Janvier 2025 — 3^e épisode**
Deux nouveaux épisodes convulsifs, fièvre à 39,2 °C, asthénie, lésions maculo-papuleuses du tronc et des membres supérieurs, **pleurésie**, **endocardite** et **protéinurie très abondante (+++)**. Suspicion initiale de syndrome DRESS.



IRM 03/2023 : hypersignaux de la substance blanche



IRM 04/2024 : hypersignaux hippocampiques bilatéraux



Lésions croûteuses intercostales

Méthodes

- **Exploration pluridisciplinaire répétée à chaque épisode** : IRM cérébrale séquentielle, bilan biologique standard, analyse du LCR, biopsie cutanée.
- **Bilan immunologique** : facteurs antinucléaires (FAN), complément (C3, C4), anticorps anti-DNA natif et détection des **anticorps anti-NMDAR**.

Résultats

2^e épisode — 04/2024
Hypersignaux FLAIR hippocampiques et insulaires bilatéraux, sans saignement ni prise de contraste, **compatibles avec une encéphalite limbique. Anti-NMDAR fortement positifs (+++)**, FAN négatifs.

3^e épisode — 01/2025
Biopsie cutanée écartant le DRESS. **FAN positifs** (homogènes faibles), **anti-DNA positifs**, **complément fortement consommé**, **anti-NMDAR toujours fortement positifs (+++)**. IRM : cavités ischémiques séquellaires cernées de gliose, **compatibles avec une vascularite**.

Discussion

- Devant le 2^e épisode, le diagnostic d'**ELAI à anti-NMDAR** a été retenu et traité (Tegretol, corticothérapie IV). La rechute multisystémique de 2025 a fait remettre ce diagnostic en question au profit d'un **LES**, confirmé selon les **critères ACR/EULAR 2019**.
- La persistance des anti-NMDAR s'explique par un **mimétisme moléculaire** : le pentapeptide (Asp/Glu-Trp-Asp/Glu-Tyr-Ser/Gly) de la sous-unité **NR2** imite l'ADN, rendant ce récepteur une cible croisée des anticorps anti-ADN et anti-NMDAR, ce qui explique les troubles neurologiques et thrombotiques du SNC.
- Le diagnostic initial d'ELAI a finalement été **redéfini en neurolupus avec atteinte rénale** ; traitement combinant **Plaquenil, Précortyl et Endoxan**.

Conclusion

- Les manifestations neuropsychiatriques du LES peuvent mimer **cliniquement, radiologiquement et biologiquement** une encéphalite auto-immune à anti-NMDAR, sur plusieurs épisodes successifs.
- Toute **rechute atypique** impose une **réévaluation systémique complète** pour ne pas méconnaître un neurolupus, dont le pronostic vital dépend de la rapidité de la prise en charge.